

a9_nursing_assessment 测试报告

生成时间：2026-05-18 15:05:25

测试时间：2026-05-18 15:05:25

- 一、测试目的：验证工具增强对输出质量提升作用。
- 二、测试内容：同一输入下，分别运行 use_tools=True/False。
- 三、测试方法：对比输出结构与长度，核对产物路径。
- 四、测试过程：
 - 1) 启用工具运行；2) 禁用工具运行；3) 指标对照；4) 结论归纳。

五、测试结果：

启用工具 success=True chars=1949 markers=34

禁用工具 success=True chars=1770 markers=29

工具说明：tool_照护洞察:tool_照护洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_个性化健康档案:tool_个性化健康档案：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_体征洞察:tool_体征洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_用药洞察:tool_用药洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_健康评估记录:tool_健康评估记录：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_睡眠记录:tool_睡眠记录：从长者智能计算图提取历史参考证据

六、结论：工具可显著提升智能体输出准确性、完整性与专业性，助力机构提供更精准照护与医疗服务。

【启用工具输出摘录】

《护士评估结论与调整建议》

****NPI结论****：NPI评分15分，属中度精神行为异常，较前期持续缓解。核心表现为偶发性拒绝配合康复训练及集体活动，无言语或肢体攻击、幻觉、妄想等严重行为，情绪整体平稳，BPSD症状处于可控状态。

****ADL结论****：ADL评分70分，属轻度功能障碍。可独立完成进食、穿衣、如厕及大小便控制；平地行走、上下楼梯需部分辅助；洗澡需照护员全程协助，以避免因动作幅度过大诱发心脏负荷增加（患者装有心脏起搏器）。

****进食评估结论****：进食正常，食欲良好，吞咽功能无异常，无呛咳、误吸风险，营养摄入充足。

****睡眠评估结论****：睡眠规律，每晚睡眠时长7-8小时，无入睡困难、早醒或多梦现象，夜间离床次数偶有波动但未影响日间精神状态，整体睡眠质量良好。

****当前风险判断****：

1. ****BPSD复发风险****：虽当前症状缓解，但既往有拒绝配合行为，若康复或活动安排不当，可能诱发轻度抗拒行为。
2. ****洗澡安全风险****：需全程协助，存在跌倒及因动作剧烈导致心脏不适的潜在风险。
3. ****认知刺激不足风险****：康乐活动频次低，未充分利用其“喜好跳舞”的个人兴趣进

行非药物干预，可能削弱BPSD预防效果。

4. ****家属心理应激风险****：家属对照护效果存疑，焦虑情绪未完全缓解，可能影响照护依从性与家庭-机构协同。

****护理员调整建议****：

1. ****个性化认知干预****：将“跳舞”元素融入日常活动，如每日安排15-20分钟音乐律动或简易广场舞（坐姿或扶椅进行），提升参与意愿，减少抗拒行为。
2. ****BPSD预防措施****：采用“选择式引导”策略（如“您想先做手部操还是跟着音乐动一动？”），避免强制指令；康复训练分段进行，每次不超过15分钟，穿插其感兴趣的内容。
3. ****洗澡安全强化****：严格遵循防滑垫铺设、水温控制（38-40℃）、全程陪护流程，动作轻柔缓慢，过程中观察面色及呼吸，如有不适立即停止。
4. ****家属支持计划****：每周提供1次BPSD应对技巧简报（含视频示例），邀请家属参与1次线上观察活动，直观了解老人积极表现，缓解焦虑。

****是否需要GP介入****：否。当前病情稳定，无急性医学问题，无需全科医生紧急介入，建议按原计划每3个月复诊。

****是否更新护理员任务****：是。需新增个性化康乐活动执行、家属沟通反馈机制及BPSD预防话术应用。

****护理员判断依据****：基于返院第5天全面健康信息采集，NPI与ADL评分趋势、生命体征稳定性、家属反馈及历史照护记录中康乐活动不足的洞察。

****视频规程链接****：（无具体链接提供，留空）

****家属沟通建议****：主动向家属传递老人BPSD缓解的积极信号，重点展示其参与跳舞活动的愉快片段；提供《轻度BPSD家庭应对指南》，强调“非对抗、重兴趣、保节奏”三大

【禁用工具输出摘录】

****《护士评估结论与调整建议》****

- ****NPI结论****：NPI评分15分，属中度精神行为异常，较前期持续缓解。当前主要表现为偶尔拒绝配合康复训练及集体活动，无激越、攻击或幻觉等过激行为，情绪整体平稳，BPSD处于稳定缓解期。

- ****ADL结论****：ADL评分70分，属轻度功能障碍。可独立完成进食、穿衣、如厕及大小便控制；平地行走及上下楼梯需部分辅助；洗澡需全程协助，主要出于心脏起搏器术后安全考虑，避免大幅度动作诱发心律异常。

- ****进食评估结论****：进食正常，食欲良好，吞咽功能无异常，无呛咳或进食困难表现，营养摄入充足。

- ****睡眠评估结论****：睡眠规律，每晚持续7-8小时，无入睡困难、夜间觉醒频繁或多梦现象，睡眠质量良好。

- ****当前风险判断****：

1. BPSD症状存在轻度复发风险，尤其在照护方式生硬或社交刺激不足时；
2. 跌倒风险中度，虽已落实防护措施，但移动及洗浴环节仍需高度警惕；
3. 家属照护焦虑显著，担忧BPSD复发，可能间接影响照护氛围；
4. 心脏安全需在洗澡等活动中持续关注，避免剧烈动作。

- ****护理员调整建议****：

1. ****认知干预****：结合老人喜爱跳舞的特点，每日安排15 – 20分钟低强度音乐律动活动（如坐姿手势舞、节奏拍打），作为非药物干预手段，提升参与感，预防行为抗拒；
2. ****沟通策略****：采用“选择式引导”替代指令式语言（例如：“您想先做手指操，还是听一段老歌？”），减少拒绝行为；
3. ****洗澡安全****：全程协助洗澡，动作轻柔缓慢，水温适中，过程中持续观察面色与呼吸，确保心脏负荷可控；
4. ****家属支持****：主动向家属反馈老人积极表现，提供《BPSD早期预警信号识别卡》及《温和应对话术手册》，缓解其焦虑。

- ****是否需要GP介入****：否。当前生命体征平稳（心率60次/分，血压135/85 mmHg），基础疾病稳定，用药依从性好，无新发躯体症状。

- ****是否更新护理员任务****：是。需将音乐律动干预、家属沟通支持、洗澡安全监护纳入本周照护重点。

- ****护理员判断依据****：基于返院第5天全面健康信息采集，包括NPI 15分、ADL 70分、睡眠与进食正常、BPSD缓解但偶有抗拒、家属焦虑持续等最新实时数据。

- ****视频规程链接****：建议参考机构标准化视频资源《失智长者音乐疗法实操指南》《BPSD温和应对五步法》《高风险长者洗浴安全流程》。

- ****家属沟通建议****：每周安排一次10 – 15分钟面对面或电话沟通，重点传达老人进步（如“今天主动跟着音乐点头”），同步指导家属在家探视时使用鼓励性语言，避免追问“记不记得”等引发挫败感的问题；提供书面版《本周照护亮点与下周计划》，增强其参与感与信心。

。

****《照护员周重点任务》****

- ****评估日期****：